

Vérification des annotations — q8

Consultation sur les droits des usagers — volet organismes communautaires

Généré le 26 juillet 2026

q8 — 8. Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l'exercice des droits des usagers ?

Propriété annotée : *Quel type principal d'obstacle l'auteur identifie-t-il pour l'exercice des droits des usagers ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 108 réponses (84 internet, 24 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Méconnaissance / manque d'information	33	30.6%	25	8
Accès limité / manque de ressources	26	24.1%	16	10
Complexité bureaucratique et procédurale	16	14.8%	14	2
Manque d'accompagnement / peur et épuisement	13	12.0%	10	3
Barrière linguistique et communication	11	10.2%	10	1
non classable	9	8.3%	9	0
Total	108		84	24

Méconnaissance / manque d'information (n=33)

#5 • internet

La compréhension.

#6 • internet

la non connaissance de leurs droits

#12 • internet

Ne connaisse pas leurs droits et se disent que de toute façon, ça ne servira à rien.

#18 • internet

la connaissance des droits

#24 • internet

Selon nous, les principaux obstacles à l'exercice des droits des usagers incluent le manque d'information claire sur leurs droits et les recours disponibles, ainsi que la complexité du réseau de la santé et des services sociaux, qui peut être difficile à naviguer.

Les délais d'attente, le manque de ressources, les barrières administratives et linguistiques peuvent également freiner l'accès aux services.

Nous observons aussi que la stigmatisation liée à la santé mentale, à la consommation, à l'itinérance, au handicap ou à d'autres situations de vulnérabilité peut nuire à la qualité des services reçus et décourager certaines personnes de demander de l'aide.

Enfin, plusieurs obstacles sont liés aux déterminants sociaux de la santé — pauvreté, instabilité résidentielle, isolement social, handicap, neurodiversité, traumatisme — qui peuvent limiter la capacité

des usagers à défendre leurs droits dans un système déjà complexe.

#25 • internet

À partir de l'expérience quotidienne de l'Académie Stella auprès des personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale, nous pouvons identifier plusieurs obstacles majeurs qui entravent l'exercice réel des droits des usagers dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ces obstacles sont de nature diverse, parfois structurels, parfois culturels, parfois strictement individuels, mais ils se conjuguent généralement pour créer un parcours semé d'embûches, particulièrement décourageant pour des personnes déjà fragilisées.

Le premier obstacle, et sans doute le plus fondamental, est la méconnaissance des droits eux-mêmes. Beaucoup d'usagers ignorent tout simplement qu'ils ont des droits, ou ne connaissent pas l'étendue réelle de ceux-ci. Le Code civil du Québec, la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et plusieurs autres textes juridiques consacrent pourtant des protections importantes. Mais sans connaissance de ces protections, il est impossible de les invoquer. Cette méconnaissance est encore plus prononcée chez les personnes ayant un faible niveau de littératie, chez les nouveaux arrivants, chez les personnes âgées ou chez celles vivant avec une déficience intellectuelle en plus d'un trouble de santé mentale. L'information disponible, souvent rédigée dans un langage juridique ou bureaucratique, demeure inaccessible à une grande partie de la population qui en aurait pourtant le plus besoin.

Le deuxième obstacle est la stigmatisation associée aux troubles de santé mentale. Malgré les campagnes de sensibilisation des dernières années, les préjugés demeurent profondément ancrés dans la société et, trop souvent, au sein même du réseau de la santé. Les personnes vivant avec un trouble de santé mentale voient régulièrement leur parole minimisée, réinterprétée à travers le prisme de leur diagnostic, ou purement et simplement écartée. Lorsqu'une personne en détresse psychologique tente de dénoncer une atteinte à ses droits, on lui répond trop souvent que sa perception est faussée par sa condition, plutôt que d'examiner sérieusement la situation qu'elle décrit. Cette stigmatisation constitue un obstacle invisible mais redoutable, car il décrédibilise d'entrée de jeu la parole des personnes concernées.

Le troisième obstacle est la complexité administrative et bureaucratique du réseau. Pour faire valoir un droit, il faut souvent naviguer entre plusieurs instances, comprendre des procédures différentes selon le type de plainte, respecter des délais précis, fournir des documents multiples et maintenir une persévérance à toute épreuve. Le régime d'examen des plaintes, bien qu'instauré pour protéger les usagers, demeure complexe à comprendre et à utiliser. Entre le commissaire local aux plaintes, le Protecteur du citoyen, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Tribunal administratif du Québec, le Curateur public et les différents ordres professionnels, l'utilisateur se perd rapidement et ne sait plus à qui s'adresser ni dans quel ordre. Cette complexité décourage même les personnes les mieux outillées et encore davantage celles qui vivent avec un trouble de santé mentale.

Le quatrième obstacle est la peur des représailles. De nombreux usagers hésitent à dénoncer une atteinte à leurs droits par crainte des conséquences sur les services qu'ils reçoivent ou qu'ils recevront. Cette peur est particulièrement présente chez les personnes dépendantes d'un suivi continu, comme c'est souvent le cas en santé mentale. Porter plainte contre un psychiatre alors qu'on sait devoir le revoir dans quelques mois, dénoncer un comportement inapproprié de la part d'un intervenant alors qu'on dépend de son équipe pour ses soins, tout cela constitue un risque perçu comme trop grand. Même lorsque les mécanismes garantissent théoriquement la confidentialité et l'absence de représailles, la perception subjective du risque suffit à dissuader l'utilisateur d'agir.

Le cinquième obstacle est l'épuisement des personnes concernées. Faire valoir ses droits exige du temps, de l'énergie, de la clarté mentale, une capacité à écrire, à téléphoner, à se déplacer, à répéter son histoire à plusieurs interlocuteurs, à supporter des délais parfois longs. Or, les personnes vivant

avec un trouble de santé mentale sont justement celles dont ces ressources sont les plus limitées. Demander à une personne en épisode dépressif majeur de remplir un formulaire de plainte, de rédiger une lettre détaillée ou de se présenter à une audience relève parfois de l'impossible. L'épuisement devient ainsi un filtre implicite qui exclut du processus de défense des droits celles et ceux qui en auraient le plus besoin.

Le sixième obstacle est la fracture numérique. De plus en plus, l'accès aux services, aux informations et aux recours passe par des plateformes numériques. Or, une part significative des usagers n'a ni les compétences, ni les équipements, ni la connectivité nécessaires pour naviguer efficacement dans cet univers. Les personnes âgées, les personnes en situation de précarité, certaines personnes vivant avec un trouble de santé mentale sévère se retrouvent exclues d'un nombre croissant de démarches. Cette exclusion numérique devient une exclusion des droits eux-mêmes.

Le septième obstacle est le manque de ressources d'accompagnement indépendantes. Les centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes existent, mais leur capacité demeure limitée au regard des besoins. Les organismes communautaires de défense de droits sont sous-financés et débordés. Les délais pour obtenir un accompagnement peuvent être longs, alors même que les délais pour déposer une plainte sont courts. Plusieurs usagers renoncent à leurs démarches non par manque de volonté, mais faute d'avoir pu être accompagnés au bon moment.

Le huitième obstacle est la méconnaissance des droits par les intervenants eux-mêmes. Nous rencontrons régulièrement des professionnels de la santé, des employés de commerces, des propriétaires ou des gestionnaires qui ignorent tout simplement le cadre juridique applicable à leur situation. Ignorance de la Charte des droits et libertés, ignorance des règles sur les chiens d'assistance, ignorance des obligations d'accommodement raisonnable, ignorance du droit à l'information, du droit au consentement, du droit à la confidentialité. Cette ignorance crée des situations où le droit est bafoué sans malice, simplement par absence de connaissance, ce qui rend les démarches de correction plus laborieuses puisqu'il faut d'abord éduquer avant de revendiquer.

Le neuvième obstacle est le déséquilibre de pouvoir entre l'utilisateur et les institutions. Devant un hôpital, une compagnie d'assurances, un propriétaire ou un employeur, l'utilisateur se retrouve en position de faiblesse structurelle. Les institutions disposent de services juridiques, de ressources financières, de temps, d'expertise. L'individu, lui, doit puiser dans ses propres ressources, souvent limitées. Ce déséquilibre conduit à des règlements inéquitables où l'utilisateur accepte moins que ce à quoi il aurait droit, simplement parce qu'il n'a pas les moyens de poursuivre la lutte.

Le dixième obstacle concerne les lacunes du cadre réglementaire lui-même. Certains droits sont insuffisamment protégés par la loi, ou protégés de manière ambiguë. La reconnaissance des chiens d'assistance en santé mentale, par exemple, demeure imparfaite au Québec, ce qui laisse place à des interprétations variables selon les lieux, les personnes et les circonstances. De même, le droit à l'accommodement raisonnable, bien qu'établi par la jurisprudence, demeure flou dans son application concrète, laissant aux employeurs et aux institutions une marge d'appréciation considérable. Ces zones grises réglementaires favorisent les atteintes aux droits et compliquent leur défense.

Le onzième obstacle est la lenteur des recours. Obtenir une décision de la Commission des droits de la personne peut prendre plusieurs années. Un recours devant le Tribunal administratif du logement, devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou devant un tribunal civil s'étire souvent sur des mois, voire des années. Cette lenteur décourage les plaignants, dont la situation a parfois évolué avant même qu'une décision ne soit rendue. Pour une personne vivant avec un trouble anxieux, l'attente prolongée d'une décision constitue en elle-même une source de détresse qui peut aggraver sa condition.

Le douzième obstacle, particulièrement pernicieux, est l'autodéfense des institutions. Lorsqu'un usager dénonce une situation, les institutions ont tendance à se protéger, à minimiser les faits, à opposer leur version des événements, à invoquer des procédures internes pour justifier leurs actions. Cette posture défensive, parfois compréhensible, transforme la défense des droits en un affrontement

inégal où l'utilisateur doit non seulement prouver l'atteinte à son droit, mais aussi surmonter la résistance organisée d'une institution. Les règlements à l'amiable, souvent privilégiés, se font fréquemment aux conditions des institutions plutôt qu'à celles des usagers.

Le treizième obstacle est le manque de transparence et de reddition de comptes. Les informations sur les plaintes traitées, sur les suites données, sur les correctifs apportés demeurent souvent peu accessibles au public. Les rapports annuels des commissaires aux plaintes, bien que publiés, sont rarement lus et rarement intégrés à une réflexion collective. L'absence de visibilité sur le traitement des plaintes crée un sentiment d'inutilité chez les usagers : pourquoi dénoncer si personne ne voit le résultat de la dénonciation, si aucun changement tangible n'en découle ?

Enfin, le quatorzième obstacle est la fragmentation des services. Un usager qui vit une atteinte à ses droits doit souvent s'adresser à plusieurs instances différentes selon la nature du problème. Un même incident peut relever à la fois du commissaire aux plaintes pour l'aspect clinique, de la Commission des droits de la personne pour l'aspect discriminatoire, de l'ordre professionnel concerné pour l'aspect déontologique, et d'un recours civil pour l'aspect indemnitaire. Cette fragmentation multiplie les démarches, les délais, les efforts, et décourage la grande majorité des plaignants.

Tous ces obstacles se conjuguent pour créer une réalité où l'exercice réel des droits des usagers demeure fortement inégalitaire. Les personnes les mieux informées, les mieux soutenues, les plus persévérantes et les plus aptes à naviguer dans les systèmes complexes parviennent à faire valoir leurs droits. Les autres, qui constituent la majorité, particulièrement parmi les personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale, renoncent, s'épuisent ou se résignent. Cette inégalité dans l'accès à la justice et à la défense des droits constitue, à notre avis, l'un des enjeux les plus criants du réseau québécois de la santé et des services sociaux. Elle appelle une réflexion profonde sur la simplification des recours, le renforcement des mécanismes d'accompagnement indépendants, la formation continue des intervenants, la lutte contre la stigmatisation et une reconnaissance pleine et entière du savoir expérientiel des usagers comme fondement de toute amélioration du système.

#31 • internet

l'accès à l'information

#35 • internet

A 21 ans on doit tout recommencer, les contacts sont perdus.

Peu d'information et de pivot central. Manque de transparence car pas de budget pour donner les services.

#39 • internet

l'accessibilité, la connaissance, l'accompagnement, l'ignorance, le manque d'information, analphabétisme

#40 • internet

La méconnaissance de ses droits

#58 • internet

l'ignorance des droits, les personnes qui tombe dans les craques du système

#63 • internet

Manque de connaissances à cet égard

Crainte de l'autorité

La bureaucratie

#65 • internet

Selon nous, les principaux obstacles à l'exercice des droits des usagers sont les difficultés de communication, le manque de sensibilisation dans certains milieux professionnels ainsi que la non-reconnaissance de leurs droits. Ces obstacles peuvent limiter l'accès à l'information, aux services et à une participation équitable dans la société.

#72 • internet

Un manque de connaissance.

#77 • internet

Ils ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte, ou porter plainte et comment documenter une plainte

#81 • internet

Méconnaissance de ces droits...

#83 • internet

Leurs manques de connaissance ou d'informations sur leurs droits.

#87 • internet

Mauvaise connaissance des droits.

#88 • internet

La communication, l'information et la prévention ciblée.

#90 • internet

La méconnaissance de leurs conditions.

#92 • internet

Manque de connaissance sur les droits, difficulté d'affirmer ses droits dans un contexte de rapports d'autorité, difficulté d'accès aux services, équipes traitantes qui sont inconfortables de partager certaines informations dans le peur de ne pas respecter la confidentialité (manque de clarté sur ce qui peut et ne peut pas être partagé).

#93 • internet

Leur connaissance de ceux-ci.

#95 • internet

La connaissance de leurs droits

#98 • internet

Méconnaissance de leur droit/ incompréhension des étapes/ des démarches

#100 • internet

Être pris au sérieux

Faire des plaintes facilement

Connaître ses droits! Très rarement les gens connaissent leurs droits et où aller pour les faire appliquer ou porter plainte. Ce n'est pas clair d'emblée.

#107 • téléphone

Le manque d'information

#111 • téléphone

Manque d'accès à la connaissance

#113 • téléphone

Le manque d'information et la difficulté d'intégrer les cas problématiques dans les structures existante.

#117 • téléphone

L'absence d'information

#121 • téléphone

Le manque de connaissance des institutions et la complexité. Le manque de temps et d'énergie, ils sont en mode survie

#122 • téléphone

La méconnaissance du système, les hommes ne savent pas à quelle porte frapper

#126 • téléphone

Le manque de connaissance

#129 • téléphone

Le manque d'information et manque d'accès au réseau

Accès limité / manque de ressources (n=26)

#1 • internet

Précarité socio économique et financement insuffisant des organismes

#14 • internet

Le faible investissement des gouvernements à offrir des services de soutien pour améliorer les conditions de vie des personnes ayant un trouble de santé mentale

#26 • internet

La demande dépasse l'offre, services non adaptés, des enjeux d'immigration,

#29 • internet

le manque de disponibilité et d'offre de soins, le manque d'accès direct et rapide

#48 • internet

l'accessibilité au service et une ressources fiable et compétente référé a la clientèle pour assurer la prestation par une infirmière et non une podologue

#49 • internet

Manque de ressources et manque d'investissement dans le RSSS

#50 • internet

Coût de la santé au privé.

#53 • internet

L'accès directement

#62 • internet

Les longs délais d'attente ;

Le manque de ressources disponibles ;

Les difficultés de communication entre les différents services ;

La fatigue et l'épuisement des familles et proches aidants ;

Le manque d'information accessible et simplifiée ;

La complexité du réseau de la santé et des services sociaux.

#68 • internet

Difficulté d'accès au réseau en général et délais interminables de prise en charge.

Équipes surchargées qui veulent prendre des décisions rapidement et négligent donc le droit des usagers à participer aux prises de décision.

Racisme et barrières culturelles des équipes.

Système qui vise le curatif plutôt que le préventif et qui travaille en silo.

#70 • internet

Le manque de connaissance sur les ressources d'aide et la capacité de se mobiliser lorsqu'on vit une trop grande détresse et que c'est au dessus de nos forces.

#84 • internet

Le manque de soin. C-A-D de travaillé sur le pourquoi le patient ne vas pas bien.

#85 • internet

Méconnaissance des droits ; pauvreté et peu de ressources

#91 • internet

Manque de connaissance du réseau, difficulté à avoir le soutien nécessaire.

#94 • internet

-Les listes d'attentes

-L'accès à l'accompagnement et/ou aux interprètes

-La méconnaissance des services existants

-Le manque d'information par rapport aux transformations du système de santé et de services sociaux.

-La difficultés que trouvent certains usagers à compléter des demandes diverses à travers les plateformes numériques.

#104 • internet

Très peu d'écoute de leurs besoins et réalité notamment dans les hôpitaux.

Dans les CLSC, très souvent, il y a beaucoup de roulement du personnel qui engendra des soins qui ne sont pas efficaces ou qui sont mal faits et cela engendre souvent des problème de santé, apparition plaie de pression, infections.

#105 • téléphone

L'accès aux services et à l'aide rapide et efficace. Présentement c'est long et difficile car les portes d'entrées sont complexes pour une personne seule et sans soutien

#106 • téléphone

Très difficile pour faire des demandes, soit pas d'ordinateur ou trop complexe de s'y retrouver. Les âgés ne sont pas à l'aise avec ce système et c'est long d'avoir des services. Les personnes très âgées ont parfois de la difficulté à s'exprimer et à demander le bon service

#108 • téléphone

L'accessibilité à la bonne personne pour les aider et le manque de connaissance

#112 • téléphone

La facilité d'accès, le manque de transparence et de facilité, le manque de moyens, les programmes internet complexes et décourageant pour nous et pour les usagers

#115 • téléphone

L'accès aux services, la méconnaissance de leurs droit, la complexité du système

#118 • téléphone

l'accès aux services, le manque de personnel, l'analphébitisation des usagers

#120 • téléphone

L'accessibilité et l'attente

#124 • téléphone

accès aux services, je ne sais pas où va l'argent de nos taxes!

#127 • téléphone

Manque d'accessibilité aux informations et suivi trop lent et les moyens de communication qui ne sont pas accessibles pour eux (internet, web...)

#128 • téléphone

Les déplacements et les difficultés pour l'accès internet pour les personnes très âgées et immigrants

Complexité bureaucratique et procédurale (n=16)

#13 • internet

Le cadre imposé à certains services tel que le service offert aux personnes sans domicile fixe qui ne considère pas une femme victime de violence conjugale hébergée en hébergement d'urgence comme sans domicile fixe

#15 • internet

Réseau de la santé centralisé et rigide, incapable d'action parce qu'allourdi par une structure dictée par des gens déconnectés du terrain et incapables de comprendre qu'un système de santé doit soigner une personne et pas un numéro.

#16 • internet

Les chemins pour faire valoir leurs droits est tortueux : un peu la maison des fous d'Astérix!

#19 • internet

la rigidité du système

#20 • internet

Les gens ne sont pas formés et ou ne prennent pas le temps adéquats afin d'expliquer clairement les options et ou entendre les réels besoins d'une personne. Si le besoin ne concorde pas au services ils sont souvent directement redirigés et doivent se débrouiller seuls.

#21 • internet

trop de protocoles administratifs et pas de solutions à offrir même si des plaintes officielles sont entamées.

Le commissaire/mécanisme de plaintes n'est plus indépendant d'un CIUSSS. Il est difficile pour les établissements d'admettre/de reconnaître quand ils ont tort.

#27 • internet

La complexité bureaucratique.

#28 • internet

- le non respect des lois, règlements, politiques et plans d'action adoptés et pourtant clairs mais souvent ignorés par les autorités des établissements

#36 • internet

Le poids que représente les procédures, le fait de devoir remplir des formulaires

#38 • internet

les institutions

#54 • internet

La complexité systémique : La lourdeur de la bureaucratie et le jargon du réseau qui rendent les recours intimidants.

La vulnérabilité des usagers : L'isolement social, l'épuisement des proches aidants et les pertes cognitives qui privent les individus des ressources nécessaires pour entreprendre des démarches.

La crainte de répercussions : La peur infondée mais réelle de voir ses services actuels réduits ou altérés si l'on formule une insatisfaction.

#78 • internet

La rigidité de la structure du CIUSSS.

#89 • internet

Le manque d'informations et de connaissances ;

Le manque de soutien et d'accompagnement lors de plaintes ;

L'immense bureaucratie du système de santé et services sociaux ;

#101 • internet

complexité recours juridiques, langue, ressources, temps, argent

#114 • téléphone

Méconnaissance de leurs droits, la complexité du système rend difficile de trouver l'information et la bonne personne

#119 • téléphone

Les milliers de différents programmes, le manque d'approche holistique globale de chaque cas

Manque d'accompagnement / peur et épuisement (n=13)

#0 • internet

Manque d'information, manque de défense respectueuse (avocat qui défend la volonté de la personne et non son intérêt), manque d'accompagnement, etc.

#4 • internet

La connaissance des recours, l'accompagnement pour les exercer

#9 • internet

Lorsqu'elles sentent qu'elle n'ont pas eu le service adéquat, elle n'ont souvent pas l'énergie nécessaire de porter plaintes.

#33 • internet

Stigmatisation, manque de temps, peur,

#34 • internet

Les dédales administratifs et la peur des représailles, mais aussi l'épuisement parental.

#42 • internet

Ils ont peur qu'on leur retire le peu qu'on leur offre s'ils font une plainte. Le processus de plainte est également complexe et SOUVENT peu concluant, alors décourageant pour les familles. Il en ressort quelques recommandations, qu'on se justifie de ne pas respecter par manque de personnel ou de budget.

#44 • internet

Les personnes âgées ont peu tendance à être en mode défense de droit et accepte tout comme une fatalité.

#64 • internet

La difficulté de compréhension de la procédure pour porter plainte. Le fait que cette clientèle a déjà beaucoup à gérer au quotidien et les usagers n'ont pas toujours l'énergie et la capacité de porter plainte.

#76 • internet

Je crois qu'à force de vouloir traiter humainement et de façon égalitaire, on oublie qu'une personne vivant avec des symptômes sévères de psychose peut avoir droit aux soins et pour cela, la confidentialité devrait pouvoir être rompue pour mieux aider la personne. L'idée n'est pas de retirer à l'utilisateur ses droits humains fondamentaux, mais de lui offrir l'encadrement nécessaire à son rétablissement.

#97 • internet

La méconnaissance de leurs droits. Où et comment puis-je me renseigner pour faire valoir mes droits? La peur d'être jugé, comment va t'on me répondre? Serais-je respecté?

#110 • téléphone

La deshumanisation, l'utilisateur a l'impression de s'adresser à une machine lors de problème, c'est trop complexe et pas assez proche de l'humain

#123 • téléphone

Ne connaissent pas les droits, ont peur des représailles, n'ont pas l'éducation ou les moyens techniques

#125 • téléphone

L'infantilisation de la clientèle, de stigmatisation

Barrière linguistique et communication (n=11)

#2 • internet

leur connaissance de leurs droits

leur aisance à communiquer, à les verbaliser, à les faire comprendre, à être écouté

#7 • internet

Les principaux obstacles sont la barrière de la langue, la complexité du système de santé , ainsi que la difficulté pour certains usagers de comprendre leurs droits.

#17 • internet

La peur des préjugés qui deviennent des micro-agressions

#23 • internet

La langue

#60 • internet

La méconnaissance linguistique et celles des codes culturels

#61 • internet

les termes utilisés notamment et le manque de proximité avec les ressources.

#67 • internet

langue

#79 • internet

la barrière de la langue au niveau de la communication et de la revendications de leurs droits

Le manque de temps , car les démarches sont parfois longues, ce qui découragent les gens

le manque d'accompagnement et de soutien tout le long des démarches / certaines personnes de sont pas autonomes

la méconnaissance des droits et des services

La violence et le contrôle que certaines personnes de l'entourage peut avoir sur la personne dont les droits sont bafoués

#80 • internet

les usagers sont stigmatisés

#99 • internet

La stigmatisation et la perception qu'on les personnes des services de santé des personnes en situation d'itinérance et vivant avec des enjeux de dépendance et de santé mentale.

#116 • téléphone

Leurs difficultés, de ne pas être informés, en situation d'itinérance ou avec des difficultés mentales... difficultés de communication avec les personnes en difficulté

non classable (n=9)

#8 • internet

Déjà répondu plus haut.

#11 • internet

6tout d

#30 • internet

Voir les questions précédentes

#32 • internet

-

#37 • internet

avoir une renocntre

#55 • internet

N.A

#66 • internet

x

#69 • internet

Racisme systémique

#71 • internet

Ne sais pas